

NAFLD e NASH: Nova Terminologia

ATUALIZAÇÃO DE NOMENCLATURA

Uma mudança de paradigma que reforça o papel central da síndrome metabólica no diagnóstico e manejo da doença hepática gordurosa.



Da Nomenclatura Antiga para a Nova

A mudança enfatiza a disfunção metabólica como eixo central da doença, eliminando a definição por exclusão.



Antes

NAFLD — Doença hepática gordurosa não alcoólica

NASH — Esteato-hepatite não alcoólica

Agora

MASLD — Doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica

MASH — Forma inflamatória com fibrose



CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS

Quando Suspeitar de MASLD?

Esteatose Hepática

Confirmada por imagem (USG, RM) ou biópsia

+ 1 Critério Metabólico

- Obesidade ($\text{IMC} \geq 25$)
- Diabetes tipo 2
- Dislipidemia
- Hipertensão arterial

ESTRATIFICAÇÃO

Papel do FIB-4 na Estratificação Inicial



Primeiro Passo Recomendado

Pelas principais diretrizes internacionais (EASL, AASLD)

Simple e Acessível

Calculado com dados laboratoriais de rotina — sem custo adicional

Triagem de Fibrose Avançada

Identifica pacientes que necessitam de investigação complementar

Como Calcular o FIB-4



Idade

Em anos



AST (TGO)

UI/L



ALT (TGP)

UI/L



Plaquetas

$10^9/L$

Fórmula

FIB-4

= Idade × AST

÷ (Plaquetas × $\sqrt{ALT}$)

Resultado adimensional — interpretado por faixas de corte clínico

INTERPRETAÇÃO

Valores de Corte do FIB-4

1

Baixo Risco

FIB-4 $< 1,3$

Fibrose avançada pouco provável

2

Zona Intermediária

FIB-4 $1,3 - 2,67$

Necessita avaliação adicional

3

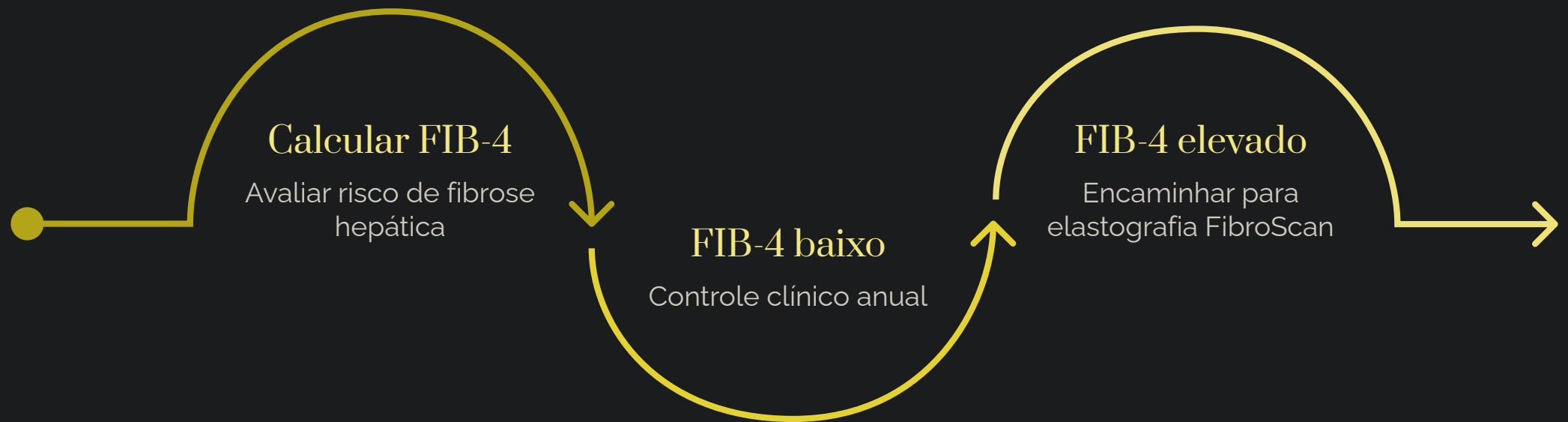
Alto Risco

FIB-4 $\geq 2,67$

Alta probabilidade de fibrose avançada

📌 Evita biópsias desnecessárias — reduz custos e riscos ao paciente quando FIB-4 $< 1,3$

Conduta Baseada no FIB-4



A elastografia hepática (FibroScan) é o método de segunda linha preferencial para confirmação de fibrose em pacientes com FIB-4 $\geq 1,3$.

MÉTODO NÃO INVASIVO

Elastografia Hepática

Indicação

FIB-4 $\geq$ 1,3 ou zona intermediária

Confirmação

Grau de fibrose (Fo-F4) sem
necessidade de biópsia

Resultado

kPa — correlaciona com estágio histológico de fibrose



Quando Indicar Biópsia Hepática?

1

Exames Inconclusivos

Elastografia e FIB-4 discordantes

2

Dados Conflitantes

Suspeita de diagnóstico alternativo ou concomitante

3

Terapias de Alto Custo

Necessária para elegibilidade a novos fármacos (ex: Resmetirom)



BASE DO TRATAMENTO

Mudança de Estilo de Vida

7%

Perda de Peso

Melhora inflamação e esteatose

10%

Regressão

Regressão da fibrose hepática
documentada

Dieta mediterrânea + exercício aeróbico + acompanhamento
multiprofissional = pilar insubstituível do tratamento.



Quando Iniciar Tratamento Farmacológico?



Indicações Principais

MASH com Fibrose $\geq$ F2

Fibrose significativa confirmada histologicamente ou por elastografia

MASH + Diabetes Tipo 2

Associação de maior risco de progressão — tratar ambas as condições

OPÇÕES TERAPÊUTICAS

Fármacos Disponíveis



Pioglitazona

Melhora histológica em MASH. Atenção: ganho de peso, retenção hídrica, risco de fratura.



Semaglutida

GLP-1: melhora peso, glicemia e perfil metabólico. Estudos de fase III em andamento para MASH.

INOVAÇÃO 2024

Terapias Emergentes

Resmetirom

Aprovado FDA — março 2024

Agonista seletivo de $\text{THR}\beta$. Indicado para MASH com fibrose F2/F3.
Primeiro fármaco aprovado especificamente para MASH.

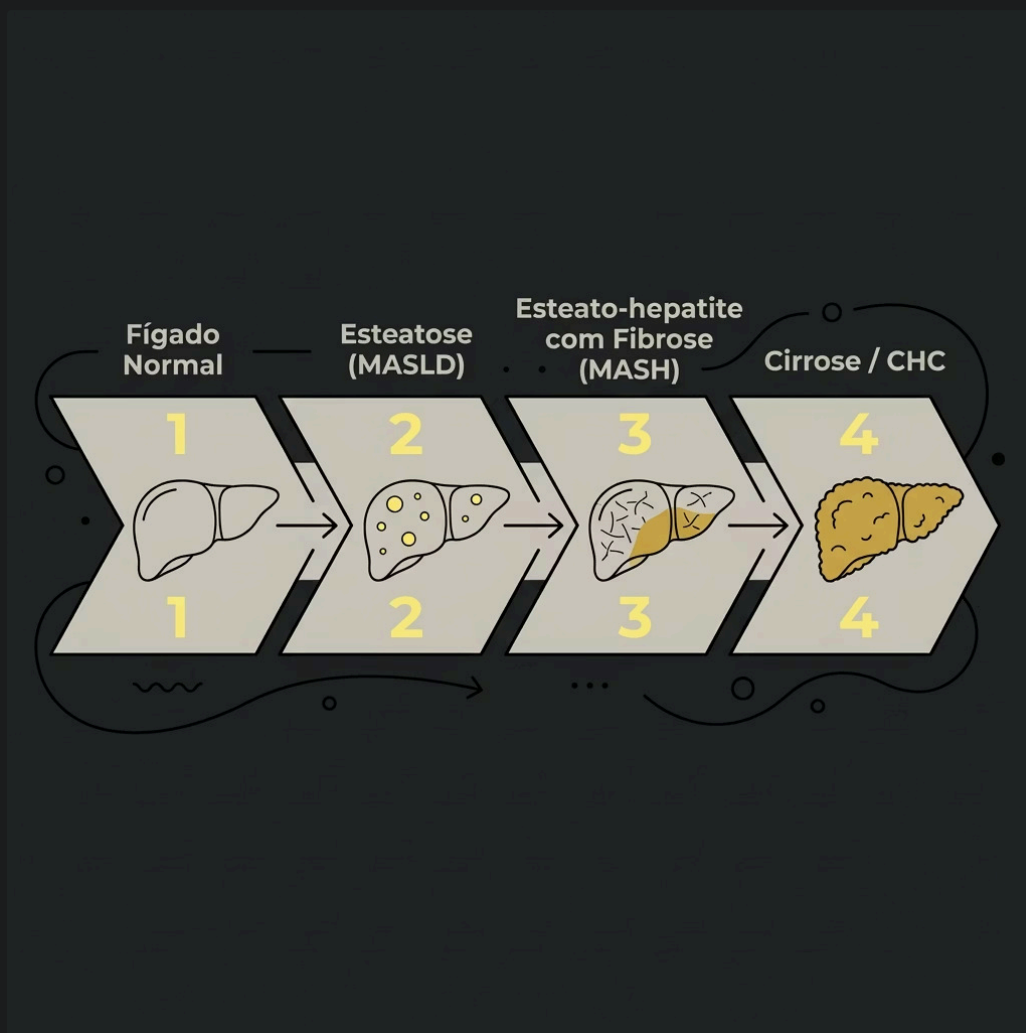
Lanifibranor

Resultados Promissores

Agonista pan-PPAR. Reduz fibrose, inflamação e esteatose em estudos de fase III.



Objetivos do Tratamento



→ Reduzir Risco Cardiovascular

Principal causa de morte no paciente com MASLD

→ Controlar Comorbidades

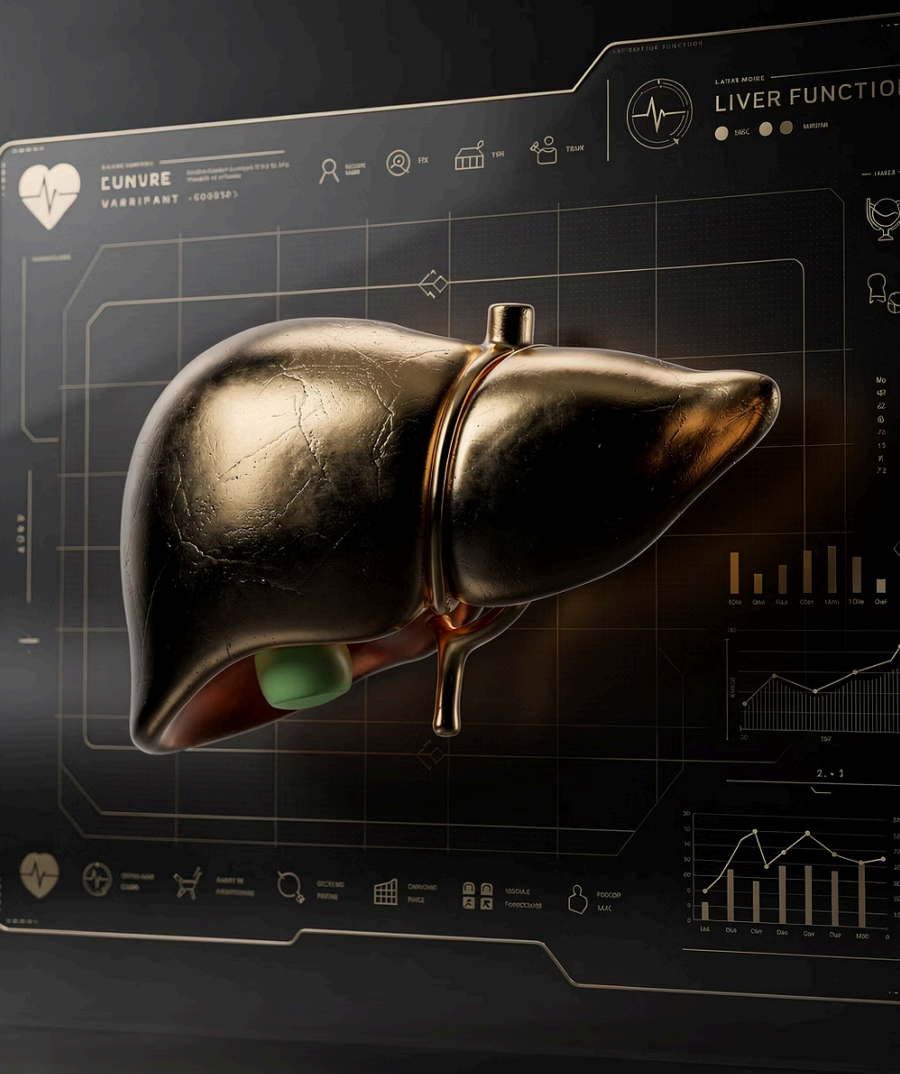
Diabetes, HAS, dislipidemia

→ Evitar Progressão para Cirrose

Interromper ou reverter fibrose

→ Reduzir Inflamação Hepática

Resolução da MASH sem piora da fibrose



RESUMO

Pontos-Chave

MASLD é Prevalente

Acomete ~25% da população global — comorbidade metabólica frequente

FIB-4 é Essencial

Primeiro passo na estratificação — simples, barato e validado

Estilo de Vida é a Base

Perda de $\geq 7-10\%$ do peso muda o curso da doença

Terapias Evoluindo

Resmetirom aprovado em 2024 — era farmacológica iniciada